



Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX
Nome: XXX
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXXX Sexo: XXX
Morada: XXXX
Localidade: XXXXx Telefone: XXXX

Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX
Médico: XXXXXX

Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXXx
Subsistema: XXXXXX
Observações: XXXX

Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: _

Observações Médicas

03-Dez-2025 09:14:00 Dr(a). Marta Isabel Neves (HUC-URG_MEDICA)

Mulher, 58 anos, recorre por dor epigástrica intensa, em ardor/queimação, c/ irradiação retroesternal ligeira, 3 dias evolução, associada a pirose e regurgitação ácida pós-prandial, agravamento marcado em decúbito. Sem hematemese, vômitos, disfagia, odinofagia, melena, rectorragias ou alteração recente do trânsito intestinal. Sem anorexia, perda ponderal, saciedade precoce ou sintomas nocturnos persistentes. Sem febre/calafrios. Nega dor torácica opressiva, dispneia, palpitações, síncope ou sudorese. Sem AINEs recentes, etilismo ou aumento de café. Refere cumprimento habitual de omeprazol 20 mg id, sem alívio significativo nos últimos dias.

AP: HTA, dislipidemia, hipotireoidismo, epilepsia focal controlada, AR sob MTX e corticoterapia crónica, anemia ferropénica crónica. Sem crises epilépticas há cerca de 2 anos. Alergia a penicilina - exantema; contraste iodado - broncospasmo ligeiro prévio. MH confirmada: levetiracetam 500 mg 2id, metotrexato 15 mg/semana, ácido fólico 5

mg/semana, prednisolona 5 mg id, perindopril 5 mg id, indapamida 1,5 mg id, levotiroxina 75 mcg id, rosuvastatina 10 mg id, omeprazol 20 mg id, sulfato ferroso 80 mg id, colecalciferol mensal.

À observação consciente, orientada, colaborante, bom estado geral, mucosas coradas e hidratadas. Sem icterícia. TA 138/76 mmHg, FC 82 bpm regular, FR 16 cpm, SpO2 98% ar ambiente, T 36,5°C, glicemia capilar 104 mg/dL. AC: S1/S2 rítmicos, sem sopros. AP: MV presente e simétrico, sem ruídos adventícios. Abdômen plano, mole e depressível, ruídos hidroaéreos presentes, doloroso à palpação profunda do epigastro, sem defesa, contractura ou descompressão dolorosa. Sem dor nos hipocôndrios, Murphy negativo, sem massas ou organomegalias. Punho-percussão lombar bilateral negativa. Sem edemas periféricos. Exame neurológico sumário sem alterações focais.

Analítica: Hb 11,1 g/dL, Ht 34,8%, VGM 80,6 fL, HGM 25,7 pg, leucócitos $7,8 \times 10^9/L$, neutrófilos $5,1 \times 10^9/L$, plaquetas $312 \times 10^9/L$; anemia microcítica ligeira compatível c/ antecedentes, sem queda conhecida relevante. PCR 3,2 mg/L. Glicemia 101 mg/dL, ureia 31 mg/dL, creatinina 0,78 mg/dL, Na 139 mmol/L, K 3,9 mmol/L. AST 22 U/L, ALT 19 U/L, FA 84 U/L, GGT 25 U/L, BT 0,4 mg/dL. Amilase 49 U/L, lipase 31 U/L. Sem evidência analítica de processo inflamatório/infeccioso, citólise/colestase ou pancreatite.

ECG: ritmo sinusal, FC 78 bpm, eixo normal, PR 160 ms, QRS estreito, sem alterações agudas de ST-T/isquemia.

Realizada EDA urgente após jejum adequado e consentimento informado. Sob sedação consciente, sem intercorrências. Esôfago permeável, sem estenose, anéis ou lesões vegetantes. Linha Z a cerca de 34 cm da arcada dentária. Mucosa do terço distal esofágico c/ eritema ligeiro, friabilidade focal e pequenas erosões lineares superficiais, não confluentes, compatível c/ esofagite de refluxo grau A de Los Angeles. Sem úlcera, hemorragia activa ou varizes. Hérnia do hiato por deslizamento, moderada, c/ impressão diafragmática a cerca de 38 cm, extensão aproximada 4 cm. Estômago c/ boa distensibilidade, conteúdo líquido claro escasso; mucosa do antro e corpo sem erosões, úlceras ou lesões suspeitas. Píloro permeável. Bulbo e D2 sem alterações relevantes. Sem colheita de biópsias em contexto urgente. Conclusão endoscópica: hérnia hiatal moderada associada a esofagite erosiva ligeira por refluxo; sem sinais de hemorragia digestiva alta ou patologia ulcerosa péptica.

Administrado pantoprazol EV e paracetamol EV, c/ melhoria progressiva da dor, passando de 8/10 para 2/10, sem vômitos e c/ tolerância de líquidos VO. Reobservada: TA 132/74 mmHg, FC 76 bpm, apirética; abdômen mantém-se mole, apenas desconforto epigástrico residual, sem sinais peritoneais.

Quadro compatível c/ DRGE exacerbada em contexto de hérnia hiatal e esofagite ligeira. Sem critérios clínicos, analíticos ou endoscópicos para internamento. Alta orientada, hemodinamicamente estável.

Indicado suspender omeprazol e iniciar esomeprazol 40 mg 2id, 30 min antes de pequeno-almoço e jantar, durante 8 semanas; posteriormente reavaliar necessidade de manutenção em dose mínima eficaz. Manter restante terapêutica habitual. Evitar AINEs. Reforçadas medidas anti-refluxo: refeições pequenas/fraccionadas, evitar deitar nas 3 h após refeições, elevar cabeceira, evitar alimentos desencadeantes, álcool, tabaco, café e refeições abundantes/gordurosas. Referenciação a Consulta de Gastrenterologia para

seguimento, reavaliação terapêutica e eventual estudo de erradicação *Helicobacter pylori*/controlo endoscópico conforme evolução.

Alertada para recorrer de imediato por hematemeses, melena, síncope, agravamento ou persistência da dor, vômitos incoercíveis, disfagia/odinofagia, febre, perda ponderal ou dor torácica/dispneia.

Notas de Enfermagem

09:02 - Admitida por meios próprios, deambulante, consciente e orientada. Queixa principal: dor epigástrica e azia intensa. Dor 8/10 à admissão. Sem náuseas/vômitos observados. Acesso venoso periférico 20G MSE, permeável. Colheitas efectuadas sem intercorrências.

10:05 - Após terapêutica EV, refere alívio parcial; dor 4/10. Sem reacção adversa medicamentosa.

13:10 - Pós-EDA, recuperada de sedação, alerta, orientada, sem dor orofaríngea significativa, sem náuseas ou vômitos. Tolerou água VO.

14:05 - Reavaliada antes de alta: dor 2/10, sem queixas novas, acompanhada por familiar. Entregues instruções de alta e sinais de alarme; verbaliza compreensão.

Diagnósticos

(K21.0) - Doença de refluxo gastroesofágico c/ esofagite

(K44.9) - Hérnia hiatal sem obstrução ou gangrena

(R10.13) - Dor epigástrica

Medicação

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

03/12/2025 09:40 | 03/12/2025 09:40 | 03/12/2025 09:40 | Pantoprazol 40 mg EV

03/12/2025 09:45 | 03/12/2025 09:45 | 03/12/2025 09:45 | Paracetamol 1 g EV

03/12/2025 | 28/01/2026 | — | Esomeprazol 40 mg VO 2id, 30 min antes das refeições

MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados

A10001 - Hemograma completo, função renal, ionograma, perfil hepático, PCR, amilase e lipase. Hb 11,1 g/dL c/ microcitose ligeira; sem leucocitose, sem elevação de PCR, função renal e ionograma preservados; provas hepáticas, amilase e lipase sem alterações.

C00012 - ECG 12 derivações. Ritmo sinusal, 78 bpm, sem alterações agudas de repolarização.

G10845 - Endoscopia digestiva alta urgente. Hérnia do hiato por deslizamento moderada, aproximadamente 4 cm; esofagite erosiva distal ligeira, grau A Los Angeles; sem úlcera péptica, hemorragia digestiva ou lesões suspeitas gástricas/duodenais.

Destino do Doente

Data: 03/12/2025 14:20

Destino: Alta para domicílio, c/ referência a Gastreenterologia.

Médico: Dr(a). Marta Isabel Neves